

16 Eylül 2026 Klinik Karar Destek ve Boylamsal Konsültasyon Raporu

Hasta: Alaattin Sönmez

Cinsiyet / Yaş: Erkek / 64

Doğum tarihi: 01.01.1962

Değerlendirme tarihi: 16.09.2026

Operasyon: 20.02.2026 acil Bentall prosedürü

Postoperatif gün: 208. gün

Veri kaynağı: ai/2026-09-16_10-33-58_alaattin-sonmez_all-data.json, "All Historical Data" dışı aktarımı

Klinik kapsam: Kardiyovasküler cerrahi, mekanik protez kapak antikoagülasyonu, rezidüel Tip B aort diseksiyonu, hemodinamik kontrol, inflamasyon/enfeksiyon izlemi ve demir eksikliği anemisi.

Klinik güvenlik notu: Bu belge klinik karar destek ve veri sentezi amacıyla hazırlanmıştır. Mekanik kapak antikoagülasyonu, antibiyotik sonrası INR yönetimi, sternal enfeksiyon değerlendirmesi ve rezidüel aort diseksiyonu izlemi doğrudan sorumlu kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, hematoloji/enfeksiyon hastalıkları ve ilgili klinik ekip tarafından yönetilmelidir. Warfarin dozundaki herhangi bir değişiklik INR izlemi ve hekim onayı olmadan uygulanmamalıdır. Özellikle 15.09.2026 tarihli INR 1,95 sonucu için aynı gün/çok kısa aralıkta klinik değerlendirme gereklidir.

1. Klinik Künye

Hasta 19.02.2026 tarihinde ani başlayan şiddetli göğüs ve sırt ağrısı ile acil başvurmuş; seri sevk sürecinde akut Stanford Tip A aort diseksiyonu ve 5,3 cm asendan aort anevrizması tanısı kesinleşmiştir. 20.02.2026 tarihinde derin hipotermik sirkülatuar arrest altında acil Bentall prosedürü uygulanmış; 32 mm polyester Dacron greft, 25 mm Carbomedics mekanik aort kapak protezi ve koroner buton reimplantasyonu gerçekleştirilmiştir. İhraç verisinde arkustan iliak bifurkasyona kadar uzanan patent rezidüel diseksiyon flebi kayıtlıdır. Bu anatomik durum yaşam boyu görüntüleme ve kan basıncı kontrolünü gerektiren kronik aort hastalığı bağlamı oluşturur (Isselbacher et al., 2022).

Postoperatif seyrinde Mart ayında gastrointestinal yakınmalar, Nisan ayında tekrarlayan hipertansif ataklar ve Temmuz sonunda ciddi sternal dehissens, enfeksiyon ve doku defekti yaşanmıştır. 23-28.07.2026 döneminde sternal yara için yoğun bakım/yara bakımı, sütürasyon, transfüzyon ve antibakteriyel tedavi kaydı bulunmaktadır. Bu seyir, 15.09.2026 tarihli inflamasyon markerlarının değerlendirilmesinde yakın klinik korelasyonu gerekli kılmaktadır (Delgado et al., 2023).

2. Yönetici Özeti — 6 KPI

KPI	16.09.2026 KLİNİK DURUMU	BOYLAMSAL DEĞİŞİM / YORUM	DURUM
7 günlük ev tansiyonu	113/76 mmHg	Son kayıt 15.09.2026: 115/77 mmHg; ev ölçümleri tedavi altında düşük-normal bantta seyrediyor	Hemodinamik olarak kontrollü
INR	1,95	10.09.2026: 2,12 → -8,0%; klinik hedef 2,0-3,0 aralığının hemen altında	Öncelikli güvenlik alarmı
Hemoglobin	9,7 g/dL	08.09.2026: 9,7 → 0,0%; 15.09.2026'da anemi sürüyor	Belirgin demir eksikliği anemisi
Ferritin	19 µg/L	Son mevcut değer 08.09.2026; veri setinde yeni ferritin Test #93 içinde bulunmuyor	Demir depoları düşük
CRP	5,7 mg/L	08.09.2026: 11,3 → -49,6%	Belirgin gerileme, hâlâ laboratuvar üst sınırının hafif üzerinde
Kilo	78,9 kg	10.09.2026: 78,4 kg; 15 ve 16.09.2026: 78,9 kg	Son 48 saatte stabil

Veri kaydına göre 15.09.2026 Test #93'te INR 1,95, CRP 5,7 mg/L, hemoglobin 9,7 g/dL, kreatinin 1,11 mg/dL, eGFR 70,89 mL/dk/1,73 m² ve trombosit 368 × 10⁹/L ölçülmüştür. Ferritin 19 µg/L, demir 15 µg/dL, UIBC 326,8 µg/dL ve B12 638 pg/mL ise son olarak 08.09.2026 Test #90'da kayıtlıdır; bu dört parametre 15.09.2026 Test #93 sonucu gibi gösterilmemelidir. Bu ayırım, veri tabanındaki otomatik klinik özet ile ham zaman damgalı TestItem kayıtları arasındaki olası uyumsuzluk nedeniyle özellikle korunmuştur.

3. Patofizyolojik Değerlendirme

3.1 Hemodinamik kontrol ve rezidüel aort diseksiyonu

Son 7 günlük ev kan basıncı ortalaması 113/76 mmHg'dir. Bu seviye 2024 ESC kılavuzundaki tedavi altındaki çoğu erişkin için önerilen 120-129/70-79 mmHg hedef bandının altında sistolik basınç sergiler; değerlendirme semptom, ortostatik tolerans ve ölçüm tekniği ile birlikte yapılmalıdır (McEvoy et al., 2024). Aort diseksiyonu sonrası kan basıncı ve nabız kontrolü aort duvar stresini azaltma amacının temel parçalarındandır (Isselbacher et al., 2022).

Mevcut ilaç şeması carvedilol eşdeğeri beta-blokaj ve perindopril ile sistemik basınç kontrolünü sürdürmektedir. Karvedilolün negatif kronotropik ve inotropik etkileri ile perindoprilin renin-anjiyotensin sistemini baskılaması, kalp hızı ve sistolik yükün azaltılmasına hizmet eder; ancak mevcut kan basıncı düşük-normal düzeyde olduğundan baş dönmesi, presenkop, ortostatik yakınma veya böbrek fonksiyonunda değişiklik gelişirse tedavi yeniden değerlendirilmelidir (Isselbacher et al., 2022; McEvoy et al., 2024).

Rezidüel patent Tip B diseksiyon flebi nedeniyle medikal kontrol, anatomik izlemin yerine geçmez. İhraç kaydında 05.05.2026 tarihli aort kontrol BT anjiyografisinde operasyon yatağının stabil olduğu, rezidüel kronik diseksiyonun inen aorta ve iliaklara devam ettiği ve abdominal aortun 38 mm olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle görüntüleme zamanlaması kalp-damar cerrahisi/aort ekibi tarafından önceki çaplar ve morfolojik değişim ile birlikte planlanmalıdır (Isselbacher et al., 2022).

3.2 INR 1,95: mekanik aort kapağı antikoagülasyonu

25 mm Carbomedics mekanik aort kapağı bulunan bir hastada yaşam boyu vitamin K antagonisti tedavisi temel tedavidir. 2025 ESC/EACTS kılavuzu, ek protrombotik risk faktörü olmayan bileaflet veya güncel nesil tek yapraklı mekanik aort kapağı için hedef INR 2,5 ve terapötik aralık 2,0-3,0 olarak verir (Praz et al., 2025).

15.09.2026 saat 15:27 Test #93'te INR 1,95 bulunması bu klinik aralığın 0,05 birim altındadır. Bir önceki 10.09.2026 INR değeri 2,12 olduğundan mutlak değişim -0,17, yüzdesel değişim yaklaşık -8,0%'dir. Daha önce 23.07-11.08 döneminde INR 1,79'dan 1,17'ye kadar düşmüş, ardından 18.08-02.09 döneminde 2,59-2,76 seviyelerine yükselmiş ve 10.09.2026'da 2,12 olmuştur. Bu dalgalanma antikoagülasyon yönetiminde yakın INR izleminin önemini destekler.

Bu sonuç, tek başına kapak trombozunun kanıtı değildir; aynı şekilde tek bir INR değerinden klinik emboli oluştuğu da söylenemez. Buna rağmen mekanik kapak ve mevcut 1,95 INR nedeniyle sorumlu antikoagülasyon ekibinin gecikmeden doz uyumu, son doz zamanı, beslenme ve vitamin K değişiklikleri, yeni ilaçlar, antibiyotik kürü, kanama bulguları ve takip INR zamanlamasını gözden geçirmesi gerekir (Praz et al., 2025). Bu rapor, 20 mg/hafta mevcut warfarin şemasının hekim gözetiminde yeniden titre edilmesi gerektiğini teyit eder; 22,5-25 mg/hafta aralığı ancak önceki yanıtlar, aktif etkileşimler ve kısa aralıklı INR izlemi dikkate alınarak klinisyen tarafından aday doz olarak değerlendirilebilir.

Klamoks kürü 04.09.2026-11.09.2026 arasında kullanılmış ve son doz 11.09.2026'da tamamlanmıştır. Beta-laktam antibiyotikler ve bazı diğer antibiyotikler warfarin etkisini değiştirebildiğinden tedavi sırasında ve sonrasında INR değişkenliği açısından ek takip gerekir. Son INR'nin antibiyotik bitiminden yaklaşık dört gün sonra 1,95'e düşmesi, yalnızca antibiyotik etkileşimi üzerinden nedensellik kurulmasına izin vermez; klinik doz geçmişi ve beslenme daha belirleyicidir (Praz et al., 2025).

3.3 Ferro Sanol Duodenal: demir Emilimi ve farmakokinetik değerlendirme

08.09.2026 laboratuvarında hemoglobin 9,7 g/dL, MCV 76,4 fL, ferritin 19 µg/L ve serum demiri 15 µg/dL bulunması mutlak demir eksikliği ile uyumlu mikrositik anemi paternidir. UIBC 326,8 µg/dL ile hesaplanan transferrin saturasyonu yaklaşık %4,4'tür. B12 638 pg/mL ve folat 4,76 ng/mL olması megaloblastik eksiklik yönünde belirgin destek vermemektedir (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

Ferro Sanol Duodenal kaydında bir kapsül 100 mg Fe²⁺ eşdeğeri ferrous glycine sulfate olarak yer almaktadır. Ürün bilgisine göre preparat gastrozistandan kapsül ve bağırsakta çözünen mikropellet yapısındadır; ürün-spesifik formülasyon ve kullanım ayrıntıları için güncel KÜB esas alınmalıdır. Demir emiliminin önemli bölümü duodenum ve proksimal ince bağırsakta gerçekleşir; demir eksikliğinde hepcidin düzeylerinin düşük olması oral demir emilimini kolaylaştırabilir (Camaschella, 2015).

Mevcut uygulama protokolü korunmalıdır: **sabah aç karnına Ferro Sanol Duodenal 100 mg Fe²⁺, bol su ile; Pantoprazol 40 mg'dan en az 1 saat önce.** Bu 1 saatlik ayırım mevcut klinik panelin ilaç uygulama protokolüdür. Pantoprazol gibi proton pompa inhibitörleri gastrik asiditeyi azaltarak bazı oral demir preparatlarının çözünürlüğünü ve emilimini azaltabilir; bu nedenle oral demir ile proton pompa inhibitörü arasında zamanlama ayırımı ve klinik yanıtı göre tekrar laboratuvar değerlendirmesi rasyoneldir, ancak tek başına 1 saatlik ayırım optimum biyoyararlanımı garanti eden evrensel bir farmakokinetik kural olarak yorumlanmamalıdır (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

Oral demir tedavisi başladıktan sonra hemoglobin yanıtı, retikülosit yanıtı, ferritin ve transferrin saturasyonu izlenmelidir. Yanıt yetersizse uyum, gastrointestinal tolerans, devam eden kan kaybı, emilim bozukluğu ve gereğinde intravenöz demir seçenekleri değerlendirilir (Snook et al., 2021). Bu hastada erkek cinsiyet ve mekanik kapak nedeniyle uzun süreli antitrombotik tedavi bulunduğu için gizli gastrointestinal kan kaybı olasılığının ayrıca araştırılması önemlidir; sadece demir verilmesi etiyolojik değerlendirme yerine geçmez (Snook et al., 2021).

3.4 PPI-demir etkileşimi

Pantoprazolün temel farmakodinamik etkisi gastrik proton pompası inhibisyonudur. Bu nedenle demir preparatının aç karnına alınması ve Panto'nun en az bir saat sonra verilmesi, mevcut ilaç kullanım protokolünün emilim açısından optimize edilmesine yönelik pratik bir düzenlemedir (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

İlaçların birlikte verilmesi tek başına demir tedavisini etkisiz ilan etmeyi gerektirmez. Tedavinin etkinliği laboratuvar yanıtı ile ölçülmelidir. Özellikle ilk kontrolte hemoglobin yükselmesi ve daha sonraki dönemde ferritin depolarının toparlanması beklenir; yanıt alınmazsa PPI gerekliliği, doz zamanı ve intravenöz demir seçenekleri hekim tarafından gözden geçirilmelidir (Snook et al., 2021).

3.5 Sternal yara ve inflamasyon remisyonu

CRP 08.09.2026'da 11,3 mg/L iken 15.09.2026'da 5,7 mg/L'ye gerilemiştir. Bu yaklaşık %49,6 azalmadır. WBC $7,97 \times 10^9/L$ 'den $9,01 \times 10^9/L$ 'ye yükselmiş olmakla birlikte laboratuvar aralığı içinde kalmıştır. Veriler sistemik inflamasyon yükünde belirgin azalma eğilimi ile uyumludur; ancak CRP'nin düşmesi sternal enfeksiyonun veya protez kapak endokarditinin mikrobiyolojik olarak eradike edildiğini kanıtlamaz (Delgado et al., 2023).

Veri setinde Temmuz sonu sternal dehissens, doku defekti, sütürasyon ve antibiyotik tedavisi kaydı vardır. 15.09.2026 itibarıyla veri tabanında pozitif kan kültürü, protez kapak vegetasyonu, paravalvüler apse veya TEE ile doğrulanmış protez kapak endokarditi bulgusu görünmemektedir. Açıklanamayan ateş, titreme, yeni veya değişmiş kapak sesi, embolik nörolojik bulgu, yeni yara akıntısı veya CRP tekrar yükselmesi durumunda kan kültürleri ve transtorasik/transözofageal ekokardiyografi klinik bağlamda değerlendirilmelidir (Delgado et al., 2023).

4. 32 Parametrelili Tümlleşik Master Tablo

Tablo okuma kuralı: “Sonuç / tarih” sütunu, ham veri kaynağındaki son ölçümü gösterir. INR, PT, PT%, aPTT ve diğer Test #93 parametreleri 15.09.2026 Test #93'e aittir. Ferritin, demir, UIBC ve B12 için veri tabanındaki son ölçüm 08.09.2026 Test #90'dır. eGFR, 15.09.2026 kreatininine dayalı dışa aktarılmış türetilmiş değerdir. Yüzdesel delta, varsa bir önceki zaman damgalı aynı kod ile hesaplanmıştır.

PARAMETRE / KOD	SONUÇ / TARİH	REFERANS	% DELTA	DURUM	KILAVUZ / KANIT
INR	1.95 INR / 15.09.2026	0.8-1.2 INR	-8.0%	HEDEF ALTI	Praz et al., 2025
PT	18.4 sn / 15.09.2026	9.6-12 sn	-7.1%	YÜKSEK	Praz et al., 2025
PT%	46.3 % / 15.09.2026	74.4-130 %	+11.0%	DÜŞÜK	Praz et al., 2025
APTT	44.4 sn / 15.09.2026	23.9-33.2 sn	-0.9%	YÜKSEK	Praz et al., 2025
CRP	5.7 mg/L / 15.09.2026	0-5 mg/L	-49.6%	SINIR ÜSTÜ	Delgado et al., 2023
WBC	$9.01 \times 10^9/L$ / 15.09.2026	$4.01-9.75 \times 10^9/L$	+13.0%	NORMAL	Delgado et al., 2023
LYM#	$3.88 \times 10^9/L$ / 15.09.2026	$1.15-3.43 \times 10^9/L$	+24.4%	YÜKSEK	Delgado et al., 2023
LYM%	43.1 % / 15.09.2026	19-48.9 %	+9.9%	NORMAL	Delgado et al., 2023
NEU#	$4.52 \times 10^9/L$ / 15.09.2026	$1.92-6.44 \times 10^9/L$	+6.1%	NORMAL	Delgado et al., 2023
NEU%	50.1 % / 15.09.2026	41.2-73.5 %	-6.4%	NORMAL	Delgado et al., 2023
NLR	1.16 - / 15.09.2026	—	-14.7%	YORUMSAL	Delgado et al., 2023
HGB	9.7 g/dL / 15.09.2026	13.4-17.6 g/dL	+0.0%	DÜŞÜK	Snook et al., 2021
HCT	30.1 % / 15.09.2026	40.5-53.6 %	+1.3%	DÜŞÜK	Snook et al., 2021
RBC	$3.93 \times 10^{12}/L$ / 15.09.2026	$4.36-6.12 \times 10^{12}/L$	+1.0%	DÜŞÜK	Snook et al., 2021
MCV	76.7 fL / 15.09.2026	75-98.3 fL	+0.4%	NORMAL	Snook et al., 2021
MCH	24.6 pg / 15.09.2026	23.2-33.2 pg	-1.2%	NORMAL	Snook et al., 2021
MCHC	32.2 g/dL / 15.09.2026	31.3-34.8 g/dL	-1.5%	NORMAL	Snook et al., 2021
RDW-CV	18.2 % / 15.09.2026	11.7-15.3 %	+2.2%	YÜKSEK	Snook et al., 2021
RDW-SD	51.8 fL / 15.09.2026	38.4-47.6 fL	+2.0%	YÜKSEK	Snook et al., 2021
PLT	$368 \times 10^9/L$ / 15.09.2026	$151-387 \times 10^9/L$	+0.8%	NORMAL	Delgado et al., 2023
MPV	9.5 fL / 15.09.2026	8.4-12.7 fL	-1.0%	NORMAL	Delgado et al., 2023
CREA	1.11 mg/dL / 15.09.2026	0.7-1.2 mg/dL	+8.8%	NORMAL	Camaschella, 2015

PARAMETRE / KOD	SONUÇ / TARİH	REFERANS	% DELTA	DURUM	KILAVUZ / KANIT
BUN	14.5 mg/dL / 15.09.2026	7-20 mg/dL	+31.8%	NORMAL	Camaschella, 2015
eGFR	70.89 mL/dk/1.73 m ² / 2026-09-15	—	—	KAYITSIZ	Inker et al., 2021
NA	138 mmol/L / 15.09.2026	136-145 mmol/L	+0.7%	NORMAL	McEvoy et al., 2024
K	5.05 mmol/L / 15.09.2026	3.5-5.5 mmol/L	+8.6%	NORMAL	McEvoy et al., 2024
CL	101 mmol/L / 15.09.2026	95-110 mmol/L	-1.9%	NORMAL	McEvoy et al., 2024
FERRITIN	19 µg/L / 08.09.2026	30-400 µg/L	—	DÜŞÜK	Camaschella, 2015; Snook et al., 2021
IRON	15 µg/dL / 08.09.2026	59-158 µg/dL	—	DÜŞÜK	Camaschella, 2015; Snook et al., 2021
UIBC	326.8 µg/dL / 08.09.2026	110-370 µg/dL	—	NORMAL	Snook et al., 2021
B12	638 pg/mL / 08.09.2026	211-946 pg/mL	—	NORMAL	Snook et al., 2021

5. Boylamsal Biyoistatistik ve Trend Analizi

5.1 Antikoagülasyon trendi

INR serisi belirgin dalgalanma göstermektedir: 16.03.2026'da 8,46, 05.05.2026'da 1,77, 12.05.2026'da 1,65, 23-27.07.2026 döneminde 1,79'dan 1,17'ye kadar düşüş, 18.08.2026'da 2,59, 25.08.2026'da 2,76, 02.09.2026'da 2,72 ve 10.09.2026'da 2,12 kaydedilmiştir. 15.09.2026'da 1,95'e gerileme, son hedef içi ölçümden sonra yeniden hedef dışına çıkışı gösterir. Tek bir düşük değer tedavi başarısızlığı olarak tanımlanamaz; buna karşın mekanik kapak nedeniyle trend, doz değişiklikleri ve kısa aralıklı INR kontrolleri birlikte ele alınmalıdır (Praz et al., 2025).

5.2 Anemi trendi

Hemoglobin 23.07.2026'da 11,3 g/dL iken 27.07.2026'da 7,7 g/dL'ye düşmüş, 28.07.2026'da 8,1 g/dL olarak kaydedilmiş ve 08.09.2026 ile 15.09.2026'da 9,7 g/dL düzeyine ulaşmıştır. Bu toparlanma, Temmuz sonundaki ağır düşüşün kısmen düzeldiğini gösterir; ancak hemoglobinin hâlen belirgin düşüktür. MCV 76,7 fL, MCH 24,6 pg, RDW-CV 18,2% ve ferritin 19 µg/L ile birlikte demir eksikliği paterni devam etmektedir (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

5.3 İnflamasyon trendi

CRP 08.09.2026'da 11,3 mg/L'den 15.09.2026'da 5,7 mg/L'ye inmiştir. Bu %49,6'lık düşüş, Klamoks kürünün tamamlanmasını takip eden dönemde inflamatuvar yükte gerileme yönünde olumlu bir biyobelirteç trendidir. Ancak sternal yara ve prostetik materyal varlığında biyobelirteç normalleşmesi klinik ve mikrobiyolojik doğrulama yerine geçmez (Delgado et al., 2023).

5.4 Böbrek fonksiyonu

Kreatinin 08.09.2026'da 1,02 mg/dL iken 15.09.2026'da 1,11 mg/dL olmuştur; değişim yaklaşık +%8,8'dir ve laboratuvar referansının üstüne çıkmamıştır. eGFR 70,89 mL/dk/1,73 m² olarak kaydedilmiştir. Bu sonuçlar, mevcut veri kesitinde akut ağır böbrek fonksiyon kaybı lehine tek başına yeterli kanıt oluşturmaz; ancak perindopril ve demir tedavisi sırasında rutin biyokimyasal takip sürdürülmelidir (McEvoy et al., 2024).

5.5 Kilo ve sıvı durumu

10.09.2026'da 78,4 kg, 11.09.2026'da 78,9 kg, 14.09.2026'da 79,7 kg, 15.09.2026'da 78,9 kg ve 16.09.2026'da 78,9 kg kayıtlıdır. 14 Eylül'deki geçici artışın iki gün içinde 78,9 kg'a dönmesi ve 16 Eylül'de aynı değer korunması, mevcut veri ile belirgin sürekli kilo artışı göstermemektedir. Kilo değişimi tek başına ödem tanısı koydurmaz; periferik ödem, akciğer konjesyonu ve günlük sıvı dengesi klinik muayene ile değerlendirilmelidir.

6. Güncel Farmakoterapi Rejimi

İLAÇ	KAYITLI GÜNCEL ŞEMA	KLİNİK BAĞLAM	İZLEM
Warfmadin / warfarin	5 mg tablet; son kayıt haftalık toplam 20 mg	Mekanik aort kapağı nedeniyle yaşam boyu VKA	INR kısa aralıkta tekrar; hekim gözetiminde doz titrasyonu (Praz et al., 2025)
Dilatrend / carvedilol	6,25 mg, günde 2 kez	Kalp hızı ve kan basıncı kontrolü	Nabız, ortostatik semptom, kan basıncı

İLAÇ	KAYITLI GÜNCEL ŞEMA	KLİNİK BAĞLAM	İZLEM
Coversyl / perindopril	5 mg, günde 1 kez	RAS blokajı ve kan basıncı kontrolü	Kreatinin, potasyum, kan basıncı (McEvoy et al., 2024)
EcopirinPro / asetilsalisilik asit	81 mg, günde 1 kez	Kayıtlı antitrombotik eşlik	Kanama bulguları ve endikasyonun periyodik yeniden değerlendirilmesi
Panto / pantoprazol	40 mg, günde 1 kez sabah	Gastrointestinal koruma / mevcut tedavi	Demir emilimi ve gastrointestinal semptomlar
Ferro Sanol Duodenal	100 mg Fe ²⁺ , günde 1 kez	Demir eksikliği anemisi	Hemoglobin ve demir indeksleri ile yanıt değerlendirmesi (Snook et al., 2021)
Kapril / kaptopril	25 mg, gerektiğinde önceki akut hipertansif atak kayıtlarında	Geçmişteki ev hipertansif atakları	Kullanım gereksiniminin hekim tarafından yeniden değerlendirilmesi
Klamoks	1000 mg, günde 2 kez; 11.09.2026'da tamamlandı	Sternal enfeksiyon tedavi kürü	Aktif tedavi olarak devam etmiyor; INR ve yara bulgusu izlemi

7. Branş Bazlı Eylem Planı

7.1 Kardiyoloji / Antikoagülasyon

15.09.2026 INR 1,95 sonucu, mekanik aort kapağı için 2,0–3,0 klinik aralığının altındadır. Öncelikli işlem, dozun kendi kendine artırılması değil, sorumlu hekim tarafından aynı gün klinik değerlendirme ve kısa aralıkta kontrol planıdır. Hekim; son warfarin dozları, uyum, beslenme, alkol kullanımı, yeni ilaçlar, Klamoks kürünün zamanlaması ve kanama/tromboemboli belirtilerini birlikte değerlendirmelidir (Praz et al., 2025).

Mekanik kapak trombozu açısından yeni dispne, senkop, yeni embolik bulgu veya protez kapak sesinde belirgin değişiklik gelişirse yalnızca INR sonucu ile yetinilmemeli; acil klinik ve görüntüleme değerlendirmesi gerekir. Protez kapak trombozu şüphesinde ekokardiyografik ve uygun görüntüleme yöntemleri klinik bağlamda kullanılır (Praz et al., 2025).

7.2 Kalp-Damar Cerrahisi / Aort Ekibi

Rezidüel patent Tip B diseksiyon flebinin önceki BT anjiyografi ölçümleri ile karşılaştırmalı izlenmesi gerekir. Yeni göğüs veya sırt ağrısı, senkop, yeni nörolojik bulgu, ekstremitte iskemisi veya belirgin kan basıncı kontrol kaybı gelişirse acil aort değerlendirmesi gerekir (Isselbacher et al., 2022).

7.3 Enfeksiyon Hastalıkları / KVC Yara Ekibi

CRP'nin 11,3'ten 5,7 mg/L'ye inmesi inflamatuvar yükte gerileme lehinedir. Bununla birlikte Temmuz sonunda ciddi sternal komplikasyon öyküsü ve prostetik materyal varlığı nedeniyle yara yerinin klinik görünümü CRP'den bağımsız olarak takip edilmelidir. Ateş, titreme, pürülan akıntı, yara açılması veya embolik bulgu varsa kan kültürleri ve hedefli ekokardiyografi değerlendirilmelidir (Delgado et al., 2023).

7.4 Hematoloji / Gastroenteroloji

Hemoglobin 9,7 g/dL, MCV 76,7 fL, ferritin 19 µg/L ve demir 15 µg/dL demir eksikliği ile uyumlu bir tablodur. Erkek hastada demir eksikliği anemisinin yalnızca replasmanla yönetilmemesi; gastrointestinal kan kaybı ve diğer nedenlerin klinik uygunluk içinde araştırılması gerekir (Snook et al., 2021).

Ferro Sanol Duodenal tedavisine uyum ve tolerans izlenmeli, gereğinde hemoglobin ve demir indeksleri yeniden ölçülmelidir. Yetersiz yanıt, devam eden kanama, emilim bozukluğu veya oral demir intoleransı gelişmesi halinde intravenöz demir seçeneği ilgili hekim tarafından değerlendirilmelidir (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

7.5 Böbrek ve Metabolizma

Kreatinin 1,11 mg/dL ve eGFR 70,89 mL/dk/1,73 m² mevcut kayıta stabil kabul edilebilecek bir aralıkta seyretmektedir. Potasyum 5,05 mmol/L laboratuvar aralığı içinde ancak üst sınıra yakın olduğundan ACE inhibitörü tedavisi sürerken tekrar biyokimya kontrolü klinik olarak uygundur. Bu rapor tek bir potasyum ölçümünden hiperpotasemi tanısı çıkarmaz.

8. Önceliklendirilmiş Klinik İzlem

Öncelik 1 — INR: 15.09.2026 INR 1,95 için sorumlu antikoagülasyon hekimiyle gecikmeden temas, klinik etkileşim/uyum değerlendirmesi ve hekim gözetiminde warfarin yeniden titrasyonu. Yeni INR kontrolünün zamanlaması klinik risk ve yapılacak doz değişikliğine göre belirlenmelidir (Praz et al., 2025).

Öncelik 2 — Demir eksikliği anemisi: Ferro Sanol Duodenal 100 mg Fe²⁺ tedavisinin sürdürülmesi ve hemoglobin yanıtının izlenmesi; erkek hastada gizli kan kaybı ve gastrointestinal nedenlerin araştırılması (Snook et al., 2021).

Öncelik 3 — Sternal enfeksiyon izlemi: CRP gerilemesi olumlu olmakla birlikte yara muayenesinin sürdürülmesi; sistemik bulgu ortaya çıkarsa kan kültürü ve prostetik kapak değerlendirmesi (Delgado et al., 2023).

Öncelik 4 — Rezidüel aort diseksiyonu: Önceki BT anjiyografilerle karşılaştırmalı görüntüleme planının kalp-damar cerrahisi/aort ekibi tarafından sürdürülmesi (Isselbacher et al., 2022).

Öncelik 5 — Hemodinamik tedavi: 113/76 mmHg ev ortalamasının semptom ve ortostatik tolerans ile birlikte değerlendirilmesi; beta-bloker ve ACE inhibitörü tedavisinin bu bağlamda izlenmesi (McEvoy et al., 2024).

9. Kırmızı Bayraklar

Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri ortaya çıktığında rutin poliklinik kontrolü beklenmeden acil tıbbi değerlendirme gerekir:

- Ani başlayan yeni ve şiddetli göğüs, sırt veya karın ağrısı (Isselbacher et al., 2022).
- Yeni konuşma bozukluğu, tek taraflı güçsüzlük, görme kaybı veya başka fokal nörolojik bulgu.
- Yeni gelişen dispne, senkop, belirgin çarpıntı veya protez kapak sesinde değişiklik.
- Ateş, titreme, pürülan sternal yara akıntısı veya yara açılması; prostetik materyal varlığında enfektif endokardit açısından değerlendirme gerekir (Delgado et al., 2023).
- Durmayan kanama, hematemez, melena veya belirgin hematokezya; mekanik kapak antikoagülasyonu ile birlikte kanama riski açısından acil değerlendirme gerekir (Praz et al., 2025).

10. Veri Kalitesi ve Yorumlama Sınırları

Bu çalışma için ham, zaman damgalı `TestItem`, ilaç değişiklikleri, tansiyon ve kilo kayıtları öncelikli veri kaynağı kabul edilmiştir. Dışa aktarım içindeki otomatik “klinik değerlendirme” metni bazı toplam ve ortalama değerleri ham kayıtlarla tam eşleştirmemektedir. Ayrıca bazı otomatik özetlerde “ilaç değişikliği yok” ifadesi bulunurken 04.09.2026 Klamoks başlangıcı, 11.09.2026 Ferro Sanol Duodenal başlangıcı ve önceki warfarin doz değişiklikleri ham ilaç değişiklik kayıtlarında görülmektedir. Bu nedenle raporda tarih damgası ve ham kayıtlar esas alınmıştır.

Özellikle ferritin, serum demiri, UIBC ve B12 değerleri 08.09.2026 Test #90'a aittir. 15.09.2026 Test #93 içinde bu dört parametre bulunmadığından 15 Eylül sonucu olarak sunulmamıştır. Bu ayırım, kullanıcının “tek gerçek kaynak” olarak belirttiği nihai JSON'un içeriğiyle uyumludur.

11. Ham INR Serisi — Antikoagülasyon Denetimi

TARİH	INR	KLİNİK DURUM
08.04.2026	2,92	Hedef içi
20.04.2026	2,03	Hedef içi
05.05.2026	1,77	Düşük
12.05.2026	1,65	Düşük
13.05.2026	1,94	Düşük
22.05.2026	2,05	Hedef içi
15.06.2026	2,18	Hedef içi
15.07.2026	2,46	Hedef içi
23.07.2026	1,79	Düşük
25.07.2026	1,70	Düşük
26.07.2026	1,38	Düşük
27.07.2026	1,17	Düşük
31.07.2026	1,18	Düşük
03.08.2026	1,21	Düşük
07.08.2026	1,55	Düşük
11.08.2026	1,70	Düşük
18.08.2026	2,59	Hedef içi
25.08.2026	2,76	Hedef içi
02.09.2026	2,72	Hedef içi
10.09.2026	2,12	Hedef içi
15.09.2026	1,95	Hedef altı

Mekanik aort kapağı için hedef aralık 2,0–3,0 kabul edildiğinde 15.09.2026 sonucu yalnızca 0,05 birim ile alt sınırın altındadır. Risk değerlendirmesi, INR'nin tek bir anlık değeri yerine tedavi geçmişi ve mekanik kapak özellikleri ile birlikte yapılmalıdır (Praz et al., 2025).

12. 15 Eylül 2026 Test #93 Özet Paneli

KOD	SONUÇ	REFERANS	DEĞERLENDİRME
INR	1,95	Klinik hedef 2,0–3,0	Hedef altı
PT	18,4 sn	9,6–12,0 sn	Yüksek
PT%	46,3%	74,4–130%	Düşük
aPTT	44,4 sn	23,9–33,2 sn	Uzamış
HGB	9,7 g/dL	13,4–17,6 g/dL	Düşük
HCT	30,1%	40,5–53,6%	Düşük
RBC	$3,93 \times 10^{12}/L$	$4,36\text{--}6,12 \times 10^{12}/L$	Düşük
MCV	76,7 fL	75,0–98,3 fL	Alt-normal; mikrositik patern devam ediyor
MCH	24,6 pg	23,2–33,2 pg	Normal laboratuvar aralığında
RDW-CV	18,2%	11,7–15,3%	Yüksek
RDW-SD	51,8 fL	38,4–47,6 fL	Yüksek
WBC	$9,01 \times 10^9/L$	$4,01\text{--}9,75 \times 10^9/L$	Normal
CRP	5,7 mg/L	0–5 mg/L	Hafif yüksek, belirgin gerilemiş
PLT	$368 \times 10^9/L$	$151\text{--}387 \times 10^9/L$	Normal
Kreatinin	1,11 mg/dL	0,7–1,2 mg/dL	Normal
BUN	14,5 mg/dL	7–20 mg/dL	Normal
eGFR	70,89 mL/dk/1,73 m ²	—	Kayda göre korunmuş filtrasyon
Na	138 mmol/L	136–145 mmol/L	Normal
K	5,05 mmol/L	3,5–5,5 mmol/L	Üst sınıra yakın
Cl	101 mmol/L	95–110 mmol/L	Normal
CK-MB	12 U/L	0–25 U/L	Normal

13. Sonuç ve Klinik Sentez

16.09.2026 itibarıyla klinik tablo iki farklı eksenı aynı anda göstermektedir. Birinci eksen, 113/76 mmHg yedi günlük ev tansiyon ortalaması, stabil kilo ve gerileyen CRP ile temsil edilen hemodinamik ve inflamatuvar iyileşme eğilimidir. İkinci eksen ise 1,95 INR ile mekanik kapak antikoagülasyonunda yeniden hedef dışına çıkış ve 9,7 g/dL hemoglobin ile süren demir eksikliği anemisi. Bu nedenle mevcut durum “tek yönlü kötüleşme” olarak tanımlanamaz; aynı zamanda tüm risklerin ortadan kalktığı bir stabilizasyon olarak da nitelendirilemez (Isselbacher et al., 2022; Praz et al., 2025; McEvoy et al., 2024; Snook et al., 2021).

En yakın klinik karar düşümü INR'dir. INR 1,95 değeri mekanik aort kapak için 2,0–3,0 terapötik aralığının altındadır ve warfarin tedavisinin kısa aralıkta klinisyen gözetiminde yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Burada amaç tek seferlik agresif doz değişikliği değil, hedef aralıkta sürdürülebilir ve güvenli antikoagülasyon sağlamaktır (Praz et al., 2025).

Demir eksikliği açısından Ferro Sanol Duodenal tedavisi yeni başlamıştır. Hemoglobin değerinin 9,7 g/dL'de değişmeden kalması, 11.09.2026 başlangıcından yalnızca birkaç gün sonra ölçülen 15.09.2026 sonucu olması nedeniyle erken dönemde tedavi başarısızlığı olarak yorumlanmamalıdır. Daha anlamlı değerlendirme için klinik olarak uygun aralıkta seri hemoglobin, ferritin ve transferrin satürasyonu takibi gerekir (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

CRP'nin %49,6 düşmesi sternal enfeksiyon/inflamasyon yükünde iyileşme lehinedir; buna rağmen prostetik materyal ve yakın dönem ciddi sternal enfeksiyon öyküsü nedeniyle klinik muayene, yara takibi ve gerektiğinde mikrobiyolojik/görüntüleme değerlendirmesi sürdürülmelidir (Delgado et al., 2023).

Bu raporun temel veri bütünlüğü kararı, 15.09.2026 Test #93 ile 08.09.2026 Test #90'ın birbirine karıştırılmamasıdır. Özellikle ferritin 19 µg/L, serum demiri 15 µg/dL, UIBC 326,8 µg/dL ve B12 638 pg/mL, veri tabanında 08.09.2026 tarihinde ölçülmüş son mevcut değerlerdir.

14. Belge ve Klinik Kullanım Notu

Belge 16.09.2026 veri kesitine göre hazırlanmıştır. Bu raporda veri tabanındaki ham zaman damgalı kayıtlar, uygulama içindeki otomatik özetlerden önce değerlendirilmiştir. Klinik karar verme sürecinde reçete değişikliği, antikoagülasyon dozu, antibiyotik seçimi, görüntüleme zamanı ve invaziv girişimler için sorumlu hekimlerin güncel klinik değerlendirmesi esastır.

Camaschella, C. (2015). Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832–1843. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1401038>

Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., Bonaros, N., Brida, M., Burri, H., Caselli, S., Doenst, T., Ederhy, S., Erba, P. A., Foldager, D., Fosbøl, E. L., Kovac, J., Mestres, C. A., Miller, O. I., Miro, J. M., Pazdernik, M., Pizzi, M. N., Quintana, E., Rasmussen, T. B., Ristić, A. D., Rodés-Cabau, J., Sionis, A., Zühlke, L. J., & Borger, M. A. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>

Isselbacher, E. M., Preventza, O., Black, J. H., 3rd, Augoustides, J. G., Beck, A. W., Bolen, M. A., Braverman, A. C., Bray, B. E., Brown-Zimmerman, M. M., Chen, E. P., Collins, T. J., DeAnda, A., Jr., Fanola, C. L., Girardi, L. N., Hicks, C. W., Hui, D. S., Jones, W. S., Kalahasti, V., Kim, K. M., Milewicz, D. M., Oderich, G. S., Ogbachie, L., Promes, S. B., Ross, E. G., Schermerhorn, M. L., Singleton Times, S., Tseng, E. E., Wang, G. J., & Woo, Y. J. (2022). 2022 ACC/AHA guideline for the diagnosis and management of aortic disease: A report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 146(24), e334–e482. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001106>

Inker, L. A., Eneanya, N. D., Coresh, J., Tighiouart, H., Wang, D., Sang, Y., Crews, D. C., Doria, A., Estrella, M. M., Froissart, M., Grams, M. E., Greene, T., Grubb, A., Gudnason, V., Gutiérrez, O. M., Kalil, R., Karger, A. B., Mauer, M., Navis, G., Nelson, R. G., Poggio, E. D., Rodby, R., Rossing, P., Rule, A. D., Selvin, E., Seegmiller, J. C., Shlipak, M. G., Torres, V. E., Yang, W., Ballew, S. H., Couture, S. J., Powe, N. R., & Levey, A. S. (2021). New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate glomerular filtration rate without race. *New England Journal of Medicine*, 385(19), 1737–1749. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102953>

McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., Daskalopoulou, S. S., Ferro, C. J., Gerds, E., Hanssen, H., Harris, J., Lauder, L., McManus, R. J., Molloy, G. J., Rahimi, K., Regitz-Zagrosek, V., Rossi, G. P., Sandset, E. C., Scheenaerts, B., Staessen, J. A., Uchmanowicz, I., Volterrani, M., & Touyz, R. M. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912–4018. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>

Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., Capodanno, D., Conradi, L., De Bonis, M., De Paulis, R., Delgado, V., Freemantle, N., Gilard, M., Haugaa, K. H., Jeppsson, A., Jüni, P., Pierard, L., Prendergast, B. D., Sádaba, J. R., ... ESC/EACTS Scientific Document Group. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>

Praz, F., Borger, M. A., Lanz, J., Marin-Cuartas, M., Abreu, A., Adamo, M., Ajmone Marsan, N., Barili, F., Bonaros, N., Cosyns, B., De Paulis, R., Gamra, H., Jahangiri, M., Jeppsson, A., Klautz, R. J. M., Mores, B., Pérez-David, E., Pöss, J., Prendergast, B. D., Rocca, B., Rossello, X., Suzuki, M., Thiele, H., Tribouilloy, C. M., & Wojakowski, W. (2025). 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 46(44), 4635–4736. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf194>

Snook, J., Bhala, N., Beales, I. L. P., Cannings, D., Kightley, C., Logan, R. P. H., Pritchard, D. M., Sidhu, R., Surgenor, S., Thomas, W., Verma, A. M., & Goddard, A. F. (2021). British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325210>

Moretti, D., Goede, J. S., Zeder, C., Jiskra, M., Chatzinakou, V., Tjalsma, H., Melse-Boonstra, A., Brittenham, G., Swinkels, D. W., & Zimmermann, M. B. (2015). Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women. *Blood*, 126(17), 1981–1989. <https://doi.org/10.1182/blood-2015-05-642223>